

ISRA

INVENTARIO DE SITUACIONES Y RESPUESTAS DE ANSIEDAD

J. J. Miguel Tobal, A. R. Cano Vindel

TEA Ediciones, S. A.

MANUAL



Investigación y Publicaciones
Psicológicas

I S R A

Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad

J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel

MANUAL

2.^a edición; revisada

(Ampliada con la inclusión de rasgos específicos)



Publicaciones de Psicología Aplicada

Serie menor, núm. 150

Publicado por TEA EDICIONES, S. A., que se reserva todos los derechos

MADRID-1988

1 2 3 4

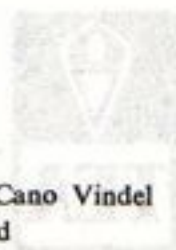
Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad

J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel

MANUAL

5.ª edición, revisada

(Ampliada con la inclusión de rasgos específicos)



Copyright © 1986, 1988 by J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel
Copyright © 1986, 1988 by TEA Ediciones, S. A., Madrid
I. S. B. N.: 84-7174-192-X
I. S. B. N.: 84-7174-194-6 (o. c.)
Depósito legal: M. - 39.798 - 1988

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este Manual, Ejemplar de la prueba u Hoja de perfil, puede ser impresa o reproducida por cualquier otro sistema, sin el permiso escrito de los propietarios del "Copyright".

Edita: TEA Ediciones, S. A. - Fray Bernardino de Sahagún, 24 - 28036 Madrid
Printed in Spain - Impreso en España por Aguirre Campano, Daganzo, 15 dpdo. - 28002 Madrid

1. Introducción

Dada la profusión de acercamientos teóricos al estudio de la ansiedad, existe un amplio número de instrumentos de autoinforme que persiguen objetivos diversos: evaluar un rasgo, situaciones temidas, reacciones a una situación específica, etc. Cada uno de estos instrumentos tiene un área de aplicación específica en que mostrarán en mayor grado su utilidad. La selección del instrumento más adecuado para cubrir unos objetivos concretos es una tarea que el experimentador, el clínico o el psicólogo de empresa, debe realizar.

Ahora bien, ateniéndonos a la evolución, tanto teórica como empírica, que en los últimos años ha tenido el estudio de la ansiedad, pensamos que son los autoinformes derivados de los modelos interactivo y neoconductual los que aportan una mayor información y logran una mayor precisión en la evaluación de la ansiedad (Miguel Tobal, 1985; Miguel Tobal y Cano Vindel, 1984a, 1984b).

Una breve revisión de estos modelos servirá para fundamentar la anterior afirmación.

1.1 — LAS TEORIAS INTERACTIVAS

Tras las duras críticas realizadas por Mischel (1968) a las teorías rasgo-estado, negando que la conducta esté determinada exclusivamente por factores internos, y los posteriores excesos del enfoque situacionista, convirtiendo a los estímulos ambientales en los principales y prácticamente únicos determinantes del comportamiento, aparecen las teorías interaccionistas. Algunos autores como Bowers (1972, 1973) y Endler (1973), proponen que el método adecuado para estudiar la personalidad debe ocuparse de cómo las características del individuo y de la situación influyen entre sí; es decir, cómo interactúan.

Las teorías interactivas explican la ansiedad en función de las características personales, las condiciones de la situación y, sobre todo, de la interacción persona por situación. El supuesto básico del que se parte es el siguiente: «Cualquier manifestación puntual (estado) de ansiedad es consecuencia de la interacción entre cierta predisposición (rasgo) existente en el individuo y características de la situación en que tiene lugar la conducta» (Bermúdez, 1983, pág. 1004). Es decir, toda reacción de ansiedad dependerá de la interacción entre

el rasgo de ansiedad del sujeto y las características *stressantes* de la situación.

Endler y Magnusson (1974, 1976) señalan los elementos básicos de esta interacción persona por situación. Son los siguientes:

- La conducta actual es función del proceso continuo de interacción entre el individuo y la situación en que se encuentra.
- El individuo es un agente activo e intencional en sus procesos de interacción.
- Respecto a la persona, los factores cognitivos y motivacionales son los principales determinantes de la conducta.
- Respecto a la situación, el significado psicológico que ésta tiene para el individuo es el factor determinante más importante.

La situación influye en la conducta del individuo

dependiendo de la forma en que éste la perciba, es decir, dependiendo de la información que esta situación proporciona y de la forma en que el individuo la interprete. Así, las diferencias individuales en comportamiento se deberán a la conjunción de dos tipos de información: la procedente de la persona y la procedente de la situación.

En cuanto a la controversia de si el comportamiento

está determinado en mayor grado por los aspectos personales o por los situacionales, cuanto más clara y definida sea la situación, mayor fuerza tendrá en la determinación del comportamiento individual, pasando las características personales a un segundo plano; a medida que la situación se convierte en más ambigua y menos precisa, la relación expuesta se invierte, siendo las características personales las que mejor explicarían el comportamiento del sujeto.

1.2 — EL ENFOQUE NEOCONDUCTISTA

A partir de los años sesenta, con la introducción de variables cognitivas por parte del neoconductismo, se modifica el concepto de ansiedad; deja de ser considerado como un fenómeno exclusivamente periférico para cobrar una significación central, cognitiva. También se pone de relieve la importancia de estudiar la ansiedad desde una perspectiva multidimensional.

La fusión de estos aspectos ha generado importantes cambios, tanto en la evaluación como en el tratamiento de la ansiedad, posibilitando una evaluación más precisa y un tratamiento cada vez más individualizado.

Se modifica la concepción unitaria del concepto de ansiedad, siendo cada vez más aceptada la idea de un triple sistema de respuesta, según el cual la ansiedad se manifiesta tanto a nivel motor como cognitivo y fisiológico. Esta teoría, propuesta inicialmente por Lang (1968), es conocida como *Teoría Tridimensional de la Ansiedad*. Se basa en la escasa correlación encontrada entre los tres sistemas de respuesta (desincronía o fraccionamiento de respuestas) y señala lo poco explicativo que resulta la utilización de un término genérico como «ansiedad» sin especificar a qué se hace referencia. Esta concepción ha traído consigo el que se comience a estudiar la ansiedad como un fenómeno complejo, centrándose en sus tres componentes (cognitivo, fisiológico y motor), ligados a situaciones específicas y definidas.

Siguiendo a Bellack y Lombardo (1984), podemos delimitar los tres sistemas o componentes de la siguiente forma:

- a) El *distress* subjetivo constituye la *reacción cognitiva* primaria que adopta la forma de sentimientos de terror, amenaza o catástrofe inminente, experimentado como «desórdenes de pánico»

o «desórdenes de ansiedad» generalizados. El *distress* subjetivo engloba pensamientos e imágenes altamente específicos.

- b) Las *respuestas fisiológicas* producidas por la ansiedad, generalmente se asocian con un incremento de la actividad del S.N.S. o del S.N.A. como resultado de la activación del S.N.C. o de la actividad neuroendocrina mediada por el S.N.C. Este incremento de la actividad producirá cambios cardiovasculares y un aumento de la actividad electrodérmica, del tono músculo-esquelético y del ritmo respiratorio.
- c) Los cambios encontrados en las *respuestas motoras* son resultado del «arousal» fisiológico y de las «cogniciones de miedo». Paul y Bernstein (1973) distinguen dos tipos: directas e indirectas.

Las respuestas motoras directas incluyen (Martin y Sroufe, 1970):

- Inquietud, tics, temblores, gesticulación, tartamudeo y la lengua se traba más a menudo.
- Reducción de la destreza motora, de la habilidad para la discriminación perceptiva, del tiempo de reacción y del aprendizaje y ejecución de tareas complejas.

Las respuestas motoras indirectas hacen referencia a las conductas de evitación y escape de la ansiedad, que no están bajo el control voluntario. Las respuestas cognitivas y fisiológicas de ansiedad actúan como estímulos discriminativos dando pie a ulteriores respuestas (por ejemplo, escape o evitación).

1.3 — APORTACIONES DE LOS ENFOQUES INTERACTIVO Y CONDUCTUAL A LA EVALUACION DE LA ANSIEDAD

La aportación más importante del enfoque interactivo, en lo que respecta a la evaluación de la ansiedad, ha sido la creación de los inventarios S-R y el desarrollo de técnicas estadísticas que cuantifican la proporción de varianza atribuida a las situaciones, a las respuestas y a la interacción entre ambas.

Del enfoque neoconductual podemos destacar:

1. El tomar el cuestionario o inventario como una medida de autoinforme del sujeto, en el que las respuestas son consideradas como muestras de conducta.
2. El énfasis puesto en la evaluación de respuestas específicas ante situaciones concretas.
3. El señalar la importancia de evaluar de forma independiente los tres sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor); cuestión ésta que ha cobrado fuerza a partir de los estudios sobre desincronía y fraccionamiento de respuesta.

El aunar las aportaciones de estos dos enfoques ha sido el propósito que nos ha servido de guía para la creación y desarrollo del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (I.S.R.A.).

No queremos cerrar este apartado sin aportar una definición de ansiedad en que se reflejen los aspectos mencionados: «Se denomina ansiedad a la respuesta, o patrón de respuestas, que engloba *aspectos cognitivos* displacenteros, de tensión y aprensión; *aspectos fisiológicos*, caracterizados por un alto grado de activación del S.N.A. y *aspectos motores* que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. La respuesta de ansiedad puede ser elicitada, tanto por estímulos externos o situacionales, como por estímulos internos, tales como pensamientos, ideas, etc., que son percibidos por el sujeto como peligrosos o amenazantes» (Miguel Tobal, 1985).

2. Objetivos

Nuestro principal objetivo es crear un instrumento que evalúe por separado la frecuencia de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana, susceptibles de generarla.

El I. S. R. A. pretende ser un instrumento preciso de evaluación de las respuestas cognitivas de ansiedad y un primer detector de las respuestas psicofisiológicas y motoras ante situaciones dadas. Nos referimos al I. S. R. A., como primer detector de respuestas psicofisiológicas y motoras, ya que una evaluación exhaustiva debería confirmar los resultados obtenidos mediante el uso de un autoinforme, con el empleo de técnicas de registro fisiológico y observación directa, respectivamente.

De cara a la evaluación, este instrumento permite la obtención de una información más detallada y completa al evaluar situaciones, respuestas, interacción entre ambas, y los tres sistemas de respuesta por separado.

Con vistas al tratamiento, ofrece la posibilidad de una exploración previa que nos de las pautas sobre situaciones más problemáticas para el sujeto, respuestas a modificar y tratamientos más indicados para el caso.

3. Descripción general

3.1 — FICHA TECNICA

- **Nombre:** (ISRA) Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad.
- **Autores:** J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel.
- **Duración:** Aproximadamente, unos cincuenta minutos.
- **Aplicación:** A partir de los dieciséis años, con un nivel cultural suficiente para comprender las instrucciones y poder ejecutar la tarea que se le exige.
- **Significación:** Evaluación de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana.
- **Tipificación:** Muestras de varones y de mujeres, extraídas de la población normal y de la población clínica.

3.2 — ESTRUCTURA DEL INVENTARIO

El I.S.R.A. es un inventario con formato S-R, es decir, que incluye tanto situaciones como respuestas. La tarea de la persona que responde consiste en evaluar la frecuencia con que en ella se manifiestan una serie de respuestas o conductas de ansiedad ante distintas situaciones.

Otra característica de este inventario es que recoge conductas o respuestas pertenecientes al sistema cognitivo, al fisiológico y al motor, por lo que se puede obtener una puntuación para cada uno de los tres sistemas citados. La obtención de estas tres puntuaciones se hace imprescindible a la luz de los estudios de fraccionamiento y desincronía, en los que se demuestra que

la ansiedad no es un constructo unitario, fruto de una activación generalizada del individuo, sino que las respuestas de sistemas distintos no siempre varían de la misma forma.

Finalmente, en el presente inventario, tanto las situaciones como las conductas o respuestas, aparecen descritas de forma precisa y específica; es decir, se describen situaciones y conductas concretas, y no abstracciones de las mismas, lo que permite validar fácilmente la información así obtenida con la de otros instrumentos, tales como el auto-registro o la escala de observación.

3.3 — ELABORACION

Para la construcción del I.S.R.A. se empleó un elevado número, tanto de situaciones como de respuestas de ansiedad. En la elección de las situaciones se tomó

como criterio que fueran situaciones susceptibles de generar ansiedad, sin que llegaran a ser acontecimientos extraordinarios que provocaran miedo en la prác-

tica totalidad de las personas. En la selección de conductas o respuestas ansiosas se tuvieron en cuenta dos cosas: primera, que estuvieran bien representadas las poblaciones de respuestas de los tres sistemas (cognitivo, fisiológico y motor); y segunda, que estuvieran redactadas de forma que describan conductas concretas. Con este criterio, puramente racional, aunque apoyado en los resultados empíricos de los trabajos con otros cuestionarios, inventarios y escalas, se construyó una primera versión del I.S.R.A. que incluía 28 situaciones y 26 respuestas, con un total de 553 *items*, contenidos en tres subpruebas o subescalas, en forma de tablas de doble entrada. La primera de las subescalas tenía, en el eje vertical, las 28 situaciones, y en el horizontal, las siete respuestas cognitivas; en la segunda, lo único que cambiaba era que las respuestas eran 12 conductas de tipo fisiológico; y, en la tercera, había siete respuestas de tipo motor. Cada *item* estaba formado por una situación y una respuesta. Había, por lo tanto, que leer una situación en el eje vertical de la tabla y una respuesta o conducta del eje horizontal y, en la casilla correspondiente a la interpretación de ambas, anotar un número del cero al cuatro, siempre que dicha casilla estuviera en blanco, pues había también casillas negras, que eran *items* que se habían eliminado, a los que no había que contestar. Los *items* que se eliminaron fueron aquellos que, o bien no tenían sentido, o bien tenían

una probabilidad mínima de ocurrencia, según el criterio de dos jueces independientes, cuyo mutuo acuerdo se tomaba como criterio de exclusión. La persona que respondía evaluaba en cada *item* la frecuencia con que se daba en ella la conducta o respuesta cuando se encontraba en esa situación.

Esta primera versión se aplicó a una muestra de personas con algún problema psicosomático y a otra muestra de personas consideradas como «normales», por no padecer ningún trastorno. Se hicieron distintos análisis de los datos obtenidos y se seleccionaron aquellos *items* que mejor discriminaban entre la muestra «normal» y la «psicosomática». Se obtuvo así la versión definitiva del I.S.R.A., en la que se respetó el mismo formato, y que cuenta con 23 situaciones y 24 respuestas, con un total de 224 *items*. En esta segunda y definitiva versión, además de haberse eliminado algunas situaciones y respuestas enteras, se aumentó el número de casillas negras; es decir, se eliminaron muchos *items*. Los 224 *items* definitivos mostraron una gran capacidad de discriminación entre la población «normal» y la «clínica». Los datos estadísticos de la primera versión pueden encontrarse en Miguel Tobal y Cano Vindel (1984b), y los correspondientes al paso de la primera a la segunda versión en Miguel Tobal (1985).

3.4 — DESCRIPCION DE LAS SUBESCALAS

Como ya hemos visto, el I.S.R.A. está formado por tres subpruebas o subescalas: una, que evalúa la ansiedad de tipo cognitivo ante distintas situaciones; otra, que evalúa la ansiedad de tipo fisiológico, en idénticas situaciones; y la última, la ansiedad de tipo motor, también en las mismas situaciones.

Las respuestas del sistema cognitivo se refieren a pensamientos y sentimientos de preocupación, miedo, inseguridad, etc.; es decir, a una serie de «rumiaciones» que llevan al individuo a un estado de alerta, desasosiego o tensión; que generan en él falta de concentración, de decisión y la idea de que las personas de su entorno observan su conducta y se dan cuenta de sus problemas y torpezas.

En el inventario fisiológico encontramos una serie de respuestas que son índices de activación del Sistema Nervioso Autónomo y del Sistema Nervioso Somático. Algunas de estas respuestas son: palpitaciones, taquicardia, sequedad de boca, dificultad para tragar, escalofríos, tiritones, temblor, sudoración, tensión muscular, respiración agitada, apnea, etc., junto con otros síntomas, tales como molestias de estómago, náuseas, mareo, dolor de cabeza, etc.

Las conductas motoras que recoge el tercer inven-

tario o subescala, son índices de agitación motora, fácilmente observables por otra persona. Incluyen dificultades de expresión verbal, tales como bloqueo o tartamudez, movimientos torpes, respuestas de huida o evitación, fumar, comer y/o beber en exceso, llanto, movimientos repetitivos con pies o manos, rascarse, hiperactividad, etc.

Para la inclusión de estas respuestas en la primera versión del I.S.R.A. ya hemos dicho que se siguió un criterio racional. Para la selección de respuestas de la versión definitiva se tuvo en cuenta un criterio empírico. Se seleccionaron las respuestas que mejor discriminaron entre la población «normal» y la «clínica». En cuanto a la validación de la clasificación que habíamos hecho de las respuestas en «cognitivas», «fisiológicas» y «motoras», se vio ampliamente corroborada por el análisis factorial de las puntuaciones de cada sujeto en cada respuesta (suma de las puntuaciones de los *items* que incluían la misma respuesta). Este análisis factorial reveló tres factores que explicarían más del 50% de la varianza total y que agrupan a las respuestas prácticamente en la misma forma en que aparecen clasificadas en el I.S.R.A., por lo que estos tres factores fueron bautizados con nombres análogos a los que damos a las tres subpruebas: al primer factor le llamamos de «activación fisiológica», al segundo, «cog-

nitivo», y, al tercero, de «activación motora». Por lo tanto, el análisis factorial del I.S.R.A. apoya los presupuestos teóricos de los que se partió para su elaboración. Es una prueba más de que las respuestas de ansiedad no covarían todas en bloque, sino que existen tres sistemas de respuestas, de manera que covarían más entre sí las que pertenecen al mismo sistema que las que pertenecen a sistemas distintos. (Véanse los resultados del análisis factorial de respuestas en el apartado «Fundamentación estadística»).

En cuanto a las situaciones de la versión definitiva del I.S.R.A., se seleccionaron aquellas en las que se daban las respuestas que mejor discriminaban entre las dos poblaciones «normal» y «clínica». Quedaron 22 de las 28 situaciones originales, más la situación abierta, que ya estaba incluida en las 28. En la situación abierta se pide al sujeto que escriba una situación, que no esté recogida en el inventario, en la que manifieste alguna de las respuestas o conductas de ansiedad, y que evalúe

la frecuencia con que se dan en él todas las respuestas del inventario ante dicha situación.

Se factorizaron las puntuaciones de todos los sujetos de una amplia muestra ante cada una de las 22 situaciones (suma de las puntuaciones de todos los ítems correspondientes a una misma situación) y aparecieron cuatro factores situacionales o rasgos específicos.

El primer factor situacional o rasgo específico de ansiedad ante situaciones que implican evaluación o asunción de responsabilidades comprende situaciones en las que el sujeto realiza alguna actividad por la que puede ser evaluado o criticado. En el segundo factor se agrupan las situaciones sexuales y de interacción social. También puede entenderse como otro rasgo específico de ansiedad. El tercero es un factor situacional o rasgo específico de ansiedad ante situaciones fóbicas. Y, por último, el factor (o rasgo específico de ansiedad) cuarto se refiere a situaciones habituales o de la vida cotidiana.

3.5 — MATERIAL DE LA PRUEBA

- Manual (con las normas de aplicación, corrección, puntuación e interpretación).
- Hoja de perfil.
- Hoja de perfil (rasgos específicos).
- Ejemplar.

4. Fundamentación estadística

En este capítulo revisaremos algunos datos psicométricos del I. S. R. A., tales como fiabilidad, validez, estructura factorial y poder de discriminación. Para más información sobre estos puntos remitimos a Miguel Tobal (1985).

4.1 — DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS

Los datos que vamos a presentar se refieren a una muestra total de 383 personas, agrupadas en cinco submuestras, tres de población general y dos de personas con problemas o trastornos clínicos.

La muestra de población general estaba formada por tres grupos: grupo 1 (N), de 129 personas, con 76 mujeres y 53 varones, con edades comprendidas entre dieciocho y sesenta y cinco años; grupo 2 (E), formado por 57 estudiantes de segundo curso de Psicología de la Universidad Complutense, de los que 50 eran mujeres; y, finalmente, el grupo 3 (L), compuesto por 44 sujetos con edades comprendidas entre dieciocho y sesenta y siete años, de los cuales 18 eran varones y 26

mujeres. Por lo tanto, la muestra total de población general incluye a 230 personas, de las que 152 son mujeres y 78 son varones.

La muestra de población con problemas clínicos estaba compuesta por el grupo 4 (P), de 131 sujetos, de edades comprendidas entre dieciséis y sesenta y cuatro años, de los cuales 55 eran varones y 76 mujeres; y el grupo 5 (C), de 22 sujetos, entre veinte y cincuenta y cuatro años, de los cuales siete eran varones y 15 mujeres.

A continuación damos algunos estadísticos descriptivos de estas muestras (tabla 1).

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las muestras empleadas

Grupo	N	Cognitivo		Fisiológico		Motor		Total	
		$\bar{X}$	s_x	$\bar{X}$	s_x	$\bar{X}$	s_x	$\bar{X}$	s_x
1 (N)	129	71.78	31.73	33.36	21.92	49.84	27.64	154.98	68.24
2 (E)	57	82.94	23.34	52.78	26.41	64.38	26.71	200.11	67.02
3 (L)	44	75.43	31.28	43.70	27.34	50.77	31.01	169.90	78.34
Total 230 (muestra de población general)									
4 (P)	131	105.58	32.43	67.32	32.86	72.54	32.38	245.45	78.92
5 (C)	22	124.99	28.47	86.20	33.76	97.31	36.67	308.52	80.12
Total 153 (muestra de población clínica)									

4.2 — PODER DE DISCRIMINACION ENTRE GRUPOS

El I.S.R.A. es altamente sensible a la hora de discriminar diferencias entre grupos con distinto nivel de ansiedad. Como muestra veamos cuáles son los resultados al comparar el grupo 1 (N), que es el más numeroso de la muestra de población general, con los grupos 4 (P) y 5 (C) de la muestra de población clínica (ver tabla 2). El I.S.R.A. Total, así como cada una de sus partes (Inventarios Cognitivo, Fisiológico y Motor) detectan diferencias significativas ($p < = 0.0000$) entre

los grupos 1 (N) y 4 (P), siendo más bajas las puntuaciones del grupo «Normal» (N), que las del grupo con trastornos «Psicosomáticos» (P). Lo mismo sucede al comparar el grupo 1 (N) con el grupo 5 (Clínico). En definitiva, tanto el I.S.R.A. Total, como cada una de sus partes (C, F y M) muestra una elevada capacidad de discriminación entre grupos con diferentes grados de ansiedad.

Tabla 2: Pruebas de diferencias de medias entre el grupo 1 (N) y los grupos 4 (P) y 5 (C)

Grupos	Prueba	T	p	Prueba	T	p
1 - 4	Cognit	-8.43	0.0000	Fisiol	-9.72	0.0000
1 - 4	Motor	-5.99	0.0000	Total	-9.84	0.0000
1 - 5	Cognit	-7.00	0.0000	Fisiol	-6.61	0.0000
1 - 5	Motor	-6.74	0.0000	Total	-9.14	0.0000

4.3 — CONSISTENCIA INTERNA

Las tres subpruebas del I.S.R.A. (C, F y M) pretenden medir aspectos diferenciales de la ansiedad: ansiedad cognitiva, ansiedad de tipo fisiológico y ansiedad motora. Estos tres tipos de ansiedad no correlacionan entre sí de forma perfecta, pero sí existe una varianza común a todos ellos. Con el fin de determinar el grado

de consistencia interna de la prueba calculamos la correlación de Pearson entre cada subprueba y con el Total. Utilizamos los grupos 1 (N) y 4 (P), dado que son los más numerosos de las muestras de población general y clínica. También utilizamos el grupo total que incluye a todos los sujetos de la muestra.

Tabla 3: Correlación entre las distintas partes del I.S.R.A. y el Total en los grupos 1 (N), 4 (P) y Total (1+2+3+4+5)

Grupos	Cognitivo	Fisiológico	Motor	Total
Cognitivo	1.0000			
Fisiológico	0.5475	1.0000		
Motor	0.4865	0.6507	1.0000	
Total	0.8381	0.8395	0.8405	1.0000
Muestra psicósomática				
Cognitivo	1.0000			
Fisiológico	0.5053	1.0000		
Motor	0.3867	0.5445	1.0000	
Total	0.7800	0.8474	0.7959	1.0000
Muestra Total				
Cognitivo	1.0000			
Fisiológico	0.6581	1.0000		
Motor	0.5591	0.6679	1.0000	
Total	0.8595	0.8904	0.8519	1.0000

Los resultados pueden verse en la tabla 3. En ella se observa que las correlaciones, tanto entre partes como con el total, son altamente significativas en todos los grupos ($p < = 0.001$). Entre partes, las mayores correlaciones se dan entre el inventario fisiológico y el

motor, mientras que las más bajas aparecen entre el cognitivo y el motor. Todos los inventarios muestran altas correlaciones con el Total, oscilando éstas entre 0.78 y 0.89.

4.4 — FIABILIDAD

Para hallar la fiabilidad del I.S.R.A. y de cada una de sus partes se utilizó el método test-retest. Para ello se aplicó la prueba por segunda vez a los grupos 2 (E) y 3 (L), dos meses después de la primera aplicación. Como puede observarse en la tabla 4, los índices

de fiabilidad del I.S.R.A. son elevados si los comparamos con los de otras pruebas de ansiedad (Cano Vindel, 1985) y más aún si tenemos en cuenta que el intervalo test-retest es de dos meses (lo habitual es un mes).

Tabla 4: **Fiabilidad test-retest en los grupos 2 (E), 3 (L) y 2+3 (E+L)**

Inventario	Grupo 2 (E)	Grupo 3 (L)	Grupo 2+3 (E+L)
Cognitivo	0.68	0.80	0.74
Fisiológico	0.79	0.74	0.77
Motor	0.75	0.82	0.78
Total	0.75	0.86	0.81

4.5 — ANALISIS FACTORIAL DE LAS RESPUESTAS

A partir de las puntuaciones de todos los sujetos ($N=383$) en cada una de las 24 respuestas de ansiedad que incluye el I.S.R.A. se realizó un análisis factorial, por el método P.C.A. (componentes principales) y rotación oblicua (DQUART). Previamente, para obtener las puntuaciones de cada sujeto en cada respuesta se habían sumado las puntuaciones de todos aquellos *items* que incluían dicha respuesta.

Los resultados pueden verse en la tabla 5. Cada respuesta se ha identificado mediante la letra «R», un número desde el 1 al 24 y una letra inicial (C, F o M) que indica el inventario o sistema de respuestas al que pertenece. Se han obtenido tres factores, con un valor propio superior a 1, que explican el 52.47% de la varianza total. El primero explica el 23.10%, el segundo el 21.18% y el tercero el 8.19% de la varianza total.

Hemos definido los factores de la siguiente forma:

FACTOR I: Activación Fisiológica

Caracterizado por altas saturaciones de las respuestas de tipo fisiológico, tales como: náuseas y mareo,

dificultades respiratorias, sequedad de boca, escalofríos, etc.; todas ellas relacionadas con una alta actividad autonómica.

FACTOR II: Cognitivo

En este factor saturan las respuestas de tipo cognitivo, tales como: temor a ser evaluado negativamente, dificultades para concentrarse, inseguridad, dificultad para tomar decisiones, etc.

FACTOR III: Activación motora

Este factor está definido por las respuestas de tipo motor. Algunas de las que obtienen más altas saturaciones son: realización de movimientos repetitivos, rasarse, moverse y hacer cosas sin una finalidad concreta, fumar o beber en exceso, etc. Todas ellas implican una alta actividad motora no dirigida a una meta concreta, o una pobre y deficiente ejecución de la conducta que pretende llevarse a cabo. Este es el factor más pobre, ya que tiene un valor propio menor que los dos anteriores, y, además, algunos *items* motores presentan saturaciones moderadas en los otros dos factores.

Estos resultados obtenidos apoyan claramente la teoría de los tres sistemas de respuestas, modelo en el que hemos basado la construcción del I.S.R.A. Recordemos que la clasificación previa de las respuestas en Cognitivas, Fisiológicas y Motoras, se había llevado a cabo con un método puramente racional, basándonos en la teoría de los tres sistemas de respuesta. Pues

bien, este análisis factorial confirma plenamente dicha taxonomía y muestra con nitidez la existencia de tres sistemas de respuesta relativamente independientes. Es una confirmación empírica de que las respuestas de ansiedad covarían más si pertenecen a un mismo sistema que cuando pertenecen a sistemas distintos.

Tabla 5: Análisis factorial de las respuestas y correlación entre factores

		FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3
FR15	22	0.864	0.0	0.0
FR14	21	0.828	0.0	0.0
FR16	23	0.817	0.0	0.0
FR17	24	0.696	0.0	0.0
MR18	25	0.690	0.0	0.0
FR8	15	0.684	0.0	0.0
FR11	18	0.679	0.0	0.0
FR13	20	0.672	0.0	0.0
FR10	17	0.618	0.0	0.0
FR9	16	0.579	0.0	0.0
CR7	14	0.0	0.863	0.0
CR6	13	0.0	0.828	0.0
CR3	10	0.0	0.811	0.0
CR4	11	0.0	0.795	0.0
CR2	9	0.0	0.762	0.0
CR5	12	0.0	0.677	0.0
CR1	8	0.0	0.669	0.0
MR19	26	0.0	0.313	0.658
MR22	29	0.0	0.323	0.685
MR20	27	0.0	0.0	0.653
MR21	28	0.0	0.449	0.0
FR12	19	0.353	0.255	0.0
MR23	30	0.317	0.395	0.257
MR24	31	0.0	0.399	0.399
VP		5.544	5.084	1.965
		FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3
FACTOR	1	1.000		
FACTOR	2	0.602	1.000	
FACTOR	3	0.403	0.281	1.000

4.6 — ANALISIS FACTORIAL DE LAS SITUACIONES

Se obtuvieron las saturaciones de cada sujeto en cada una de las 22 situaciones descritas en el I.S.R.A. (suma de las puntuaciones de todos los *items* que incluyen una determinada situación). Con estas puntuaciones relativas a los 383 sujetos de toda la muestra se llevó a cabo otro análisis factorial, también por el método P.C.A. (Análisis de Componentes Principales) y rotación

DQUART (oblicua). Los resultados pueden verse en la tabla 6.

Las 22 situaciones se agrupan en cuatro factores que explican el 51.62% de la varianza total. El primero explica el 25.07%, el segundo el 9.97%, el tercero el 9.03% y el cuarto el 7.55% de la varianza total.

Los factores se han definido de la siguiente forma:

FACTOR III: Situaciones fóbicas

FACTOR I: Situaciones que implican evaluación y asunción de responsabilidades

El factor I o rasgo específico de ansiedad ante «situaciones que implican evaluación o asunción de responsabilidades» está definido por situaciones tales como la de hablar en público, hacer un examen o una prueba, tomar una decisión o resolver un problema, ser observado en el trabajo, recibir críticas o posibilidad de ser evaluado negativamente, etc.

FACTOR II: Situaciones sexuales y de interacción social

El factor situacional II o rasgo específico de ansiedad ante «situaciones sexuales y de interacción social» está formado por situaciones del tipo de, ir a una cita con una persona del otro sexo, estar muy cerca de una persona del otro sexo o en una situación sexual íntima, asistir a una reunión social o conocer gente nueva, esperar a alguien en un lugar concurrido, etc.

El factor situacional III o rasgo específico de ansiedad ante «situaciones fóbicas», incluye situaciones en las que aparece como elemento central algún estímulo típicamente fóbico, tales como viajar en avión o en barco, los lugares altos o las aguas profundas, observar escenas violentas, los dentistas y las inyecciones, las multitudes y espacios cerrados, etc.

FACTOR IV: Situaciones habituales o de la vida cotidiana

Por último, el factor situacional IV o rasgo específico de ansiedad ante «situaciones habituales o de la vida cotidiana» recoge situaciones tales como, a la hora de dormir, por nada en concreto, situaciones de trabajo o estudio, etc.

En resumen, el análisis factorial (tabla 6) refleja la existencia de cuatro tipos de situaciones generadoras de ansiedad o cuatro rasgos específicos de ansiedad, relativamente independientes.

Tabla 6: Análisis factorial de las situaciones y correlación entre factores

		FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3	FACTOR 4
S10	17	0.802	0.0	0.0	0.0
S1	8	0.769	0.0	0.0	0.0
S4	11	0.758	0.0	0.0	0.0
S9	16	0.708	0.266	0.0	0.0
S13	20	0.706	0.0	0.0	0.0
S11	18	0.697	0.0	0.0	0.0
S20	27	0.632	0.0	0.418	0.0
S3	10	0.552	0.0	0.0	0.363
S8	15	0.547	0.0	0.0	0.0
S7	14	0.0	0.873	0.0	0.0
S15	22	0.0	0.812	0.0	0.0
S12	19	0.0	0.0	0.795	0.0
S19	26	0.0	0.0	0.760	0.0
S22	29	0.0	0.0	0.0	0.753
S6	13	0.369	0.321	0.0	0.287
S16	23	0.465	0.0	0.254	0.0
S17	24	0.493	0.0	0.323	0.0
S18	25	0.448	0.483	0.0	0.0
S5	12	0.398	0.0	0.0	0.462
S2	9	0.0	0.0	0.283	0.311
S21	28	0.304	0.0	0.0	0.488
S14	21	0.0	0.406	0.412	-0.287
VP		5.517	2.194	1.968	1.661
		FACTOR 1	FACTOR 2	FACTOR 3	FACTOR 4
FACTOR	1	1.000			
FACTOR	2	0.587	1.000		
FACTOR	3	0.403	0.266	1.000	
FACTOR	4	0.411	0.319	0.237	1.000

4.7 — VALIDEZ

Aparte de la indudable *validez de contenido* del I.S.R.A., que ha sido construido siguiendo las más recientes y contrastadas teorías o modelos de la ansiedad, y de la alta *validez empírica* mostrada a la hora de discriminar entre grupos con distintos niveles de ansiedad (muestras de población clínica y de población general), se ha estudiado la *validez estructural*.

Para ello, se han seguido dos métodos: análisis factorial y correlación con otros tests.

Respecto a los análisis factoriales no vamos a añadir más sobre ellos (véanse las secciones 4.5 y 4.6); solamente resaltar que los resultados obtenidos constituyen un sólido apoyo a la validez estructural del I.S.R.A.

En cuanto a las correlaciones con otros tests, se han empleado el M.A.S. (Taylor, 1953) y el S.T.A.I. (Spiel-

berger, Gorsuch y Lushene, 1970), que son dos pruebas de uso extendido en nuestro país y de reconocida validez.

Para calcular las correlaciones entre el I.S.R.A. Total y cada una de sus partes (C, F y M) con el M.A.S. y el S.T.A.I., se han empleado los grupos 1 («Normal») y 4 («Psicosomático»), que son los que tienen mayor número de sujetos, y el grupo total, formado por los 383 sujetos de toda la muestra. Los resultados se exponen en la tabla 7. Todas las correlaciones obtenidas son significativas, con un nivel de confianza superior al uno por mil. Las correlaciones del I.S.R.A. con las otras dos pruebas son menores que las que ellas tienen entre sí. Esto no debe sorprendernos si pensamos que el M.A.S. y el S.T.A.I. son pruebas que evalúan rasgos de ansiedad, mientras que para el I.S.R.A. no es ese su objetivo.

Tabla 7: Correlación entre I.S.R.A., M.A.S. y S.T.A.I. en los grupos 1 (N), 4 (P) y Total

	Grupo 1 (N)		Grupo 4 (P)		Total	
	M.A.S.	S.T.A.I.	M.A.S.	S.T.A.I.	M.A.S.	S.T.A.I.
M.A.S.	1.0000		1.0000		1.0000	
S.T.A.I.	0.7373	1.0000	0.7089	1.0000	0.7829	1.0000
COGNITIVO	0.5407	0.6133	0.4475	0.4888	0.5881	0.5839
FISIOLÓGICO	0.4728	0.4431	0.4649	0.3896	0.5740	0.4923
MOTOR	0.4149	0.4416	0.3887	0.4912	0.4666	0.4943
TOTAL	0.5715	0.6065	0.5370	0.5647	0.6272	0.6055

5. Instrucciones para la aplicación y corrección

5.1 — APLICACION

La aplicación de la prueba debe realizarse en el siguiente orden: C (cognitivo), F (fisiológico) y M (motor); tal como figura en el cuadernillo de respuestas.

Las instrucciones que deben darse al sujeto son las indicadas en la primera página del cuadernillo. En ellas se le pide que evalúe la frecuencia con que manifiesta las distintas respuestas en cada una de las situaciones. Para evaluar esta frecuencia se ha utilizado una escala de cinco puntos, con las siguientes categorías:

- 0 = Casi nunca
- 1 = Pocas veces
- 2 = Unas veces sí, otras veces no
- 3 = Muchas veces
- 4 = Casi siempre

A continuación se le indica que sólo debe responder las casillas en blanco, anotando en el margen derecho cualquier observación que crea oportuna y solamente en el caso en que lo considere necesario.

La situación abierta (núm. 23) se utilizará sólo cuando exista una situación especialmente perturbadora para el sujeto y no esté incluida en las 22 anteriores. En este caso, se escribirá la situación en las tres hojas (C, F y M) y se responderá a todas las casillas.

Es posible que algunos sujetos presenten dudas a la hora de responder a situaciones dobles. Por ejemplo, ante la situación número 12 (*«cuando tengo que viajar en avión o en barco»*), puede ocurrir que, para alguien, viajar en barco sea placentero, mientras que viajar en avión le genere un gran temor. En estos casos, se debe pedir al sujeto que responda en función de la que le provoque un mayor temor, anotando en la columna de observaciones (margen derecho) la situación concreta a que hacen referencia sus respuestas.

La duración total de la prueba oscila entre cuarenta y sesenta minutos, sin que exista limitación de tiempo.

Cuando se aplique la prueba a sujetos con un nivel cultural muy bajo, o pacientes que presenten cierto deterioro, el examinador debe asegurarse de que el sujeto ha comprendido bien las instrucciones y la tarea a realizar, ayudándole a responder los primeros *items*. Si fuese necesario, se recurrirá a frases del tipo:

«Imagínese que...» (se le lee la situación). *«Ahora quiero que usted me diga si...»* (se le lee la respuesta), y *«cuántas veces le ocurre ésto»* (se le muestra nuevamente la escala). *«Entonces, ¿qué número pondríamos?»*.

5.2 — CORRECCION Y VALORACION

La corrección y valoración de la prueba se realiza sumando las puntuaciones dadas por el sujeto a cada *item* (casilla en blanco) de cada inventario (C, F y M).

Una forma simple y sistemática de hacerlo consiste en sumar las casillas de cada columna y anotarlo en la casilla de sumatorio (ΣR). Posteriormente, se suman

los sumatorios obtenidos y el resultado se anota en la casilla «Total». De igual forma se puede proceder con las filas (ΣS). Nota: las puntuaciones correspondientes a la situación abierta (núm. 23) no se utilizarán en estos cálculos.

La puntuación del inventario fisiológico se obtiene dividiendo el total entre 2, ya que posee doble número de ítems que el cognitivo o el motor.

Así obtendremos tres puntuaciones: una para el inventario cognitivo, otra para el fisiológico y otra para el motor, que representan las puntuaciones de cada uno de los sistemas de respuesta.

La puntuación total (rasgo) se obtiene sumando las tres anteriores, es decir:

$$P. T. = C + F/2 + M$$

Estas puntuaciones directas se convierten en centiles utilizando las tablas de baremos (tablas 8 y 9). De esta forma, podremos conocer qué posición ocupa un sujeto concreto dentro del grupo normativo correspondiente.

Es aconsejable utilizar los baremos del grupo «Normal» (o de población general) para conocer la posición de este sujeto con respecto a la población general; y, del grupo «clínico», para conocer la severidad de su grado de ansiedad.

Si se desea un análisis más detallado, deberemos centrarnos en las puntuaciones de cada respuesta (ΣR) y de cada situación (ΣS) en cada uno de los inventarios (C, F y M). Ello nos dará información sobre las respuestas más desajustadas y las situaciones más ansiógenas para el sujeto, que puede ser de utilidad para la elaboración de un programa de intervención terapéutica; o para la evaluación detallada de los efectos de una terapia determinada, en caso de utilizar el I.S.R.A. como prueba de control a lo largo de un tratamiento.

Cuando se utilicen estas puntuaciones de respuestas y situaciones debe hallarse la media aritmética de cada una de ellas. Esta se obtendrá dividiendo la puntuación del sumatorio de R (ΣR) o del sumatorio de S (ΣS) entre el número de casillas en blanco de esa R o esa S.

Tabla 8: Baremos de la muestra normal

P. centil	Puntuaciones directas								P. centil
	MUJERES				VARONES				
	Cognitivo	Fisiológico	Motor	Total	Cognitivo	Fisiológico	Motor	Total	
99	147	112	124	351	122	84	108	291	99
95	132	98	105	302	102	61	91	248	95
90	125	79	94	280	95	53	82	210	90
85	116	71	87	248	90	48	72	197	85
80	107	65	81	230	84	45	66	192	80
75	101	59	76	225	79	40	63	183	75
70	95	53	69	212	74	38	58	169	70
65	88	50	64	203	71	33	49	160	65
60	85	48	62	196	70	30	44	150	60
55	81	45	60	186	68	29	41	136	55
50	80	41	55	182	67	27	39	130	50
45	77	37	49	172	62	25	36	125	45
40	75	34	47	169	58	21	34	113	40
35	69	33	45	152	51	19	30	107	35
30	65	29	41	148	47	17	29	106	30
25	57	26	36	137	44	14	26	87	25
20	52	21	32	126	38	11	22	77	20
15	47	17	28	103	34	9	18	67	15
10	42	13	21	83	29	8	17	64	10
5	33	7	16	63	22	6	12	56	5

Tabla 9: Baremos de la muestra clínica

P. centil	Puntuaciones directas								P. centil
	MUJERES				VARONES				
	Cognitivo	Fisiológico	Motor	Total	Cognitivo	Fisiológico	Motor	Total	
99	186	168	161	499	162	136	149	405	99
95	158	135	141	422	144	108	128	368	95
90	153	124	118	393	133	96	112	324	90
85	148	111	112	344	122	90	106	299	85
80	142	101	103	318	117	87	102	289	80
75	138	95	99	310	116	79	96	264	75
70	133	86	90	299	106	74	90	256	70
65	131	80	81	294	100	65	87	238	65
60	126	76	77	283	96	60	84	232	60
55	124	74	76	273	95	58	79	222	55
50	117	70	72	260	90	53	72	211	50
45	113	65	69	248	88	51	63	204	45
40	112	61	65	238	83	47	62	195	40
35	109	59	60	234	79	42	56	193	35
30	105	54	58	227	77	37	53	185	30
25	95	50	53	213	72	35	49	175	25
20	91	48	44	204	63	32	37	167	20
15	83	44	41	195	60	26	33	150	15
10	78	37	37	185	53	24	31	127	10
5	61	35	33	150	46	21	22	104	5

5.3 — ELABORACION DEL PERFIL

Una vez finalizada la aplicación y valoración del I.S.R.A., y cuando se desee una visión gráfica y específica de las características del sujeto, se trasladarán los resultados obtenidos a la hoja de perfil.

Para ello se procederá de la siguiente forma:

- 1) La puntuación directa se convertirá en centil, utilizando el baremo del grupo «Normal».
- 2) Las cuatro puntuaciones centiles obtenidas (C, F, M y T) se introducen en el gráfico a su altura correspondiente, realizando una marca en ese punto.
- 3) Si alguna de las puntuaciones directas supera a la indicada en el centil 99 del baremo de «normales», se introducirá en el gráfico de forma directa, tomando como referencia las puntuaciones indicadas en la Hoja de perfil. Estas corresponden a los centiles 90, 95 y 99 del grupo «clínico».
- 4) Si se unen las marcas realizadas para las puntuaciones C, F y M (la Total no) mediante una línea, se obtiene el perfil del sujeto. Si se elevan desde la base unas barras, se obtiene el diagrama de barras de los resultados empíricos comparados con los sujetos de la población.

5.4 — INTERPRETACION DEL PERFIL

En el gráfico se han trazado tres líneas horizontales en las puntuaciones centiles 25, 75 y 99, que sirven de indicación para interpretar los resultados.

Estas líneas delimitan cuatro niveles de ansiedad:

- Ausencia de ansiedad o ansiedad mínima: en este nivel no se encuentra prácticamente ningún caso clínico.
- Ansiedad moderada a marcada: en esta categoría está incluida el 50% de la población «normal» (con puntuaciones medias) y un menor número de sujetos con problemas clínicos.
- Ansiedad severa: en este nivel las proporciones se invierten respecto al nivel anterior, superando

el número de sujetos «clínicos» al de los «normales».

- Ansiedad extrema: todos los sujetos incluidos en esta categoría pertenecen al grupo clínico, sin que haya una sola persona del grupo «normal» que alcance estos valores.

Para una información más detallada sobre el porcentaje de sujetos «normales» y «clínicos» incluidos en cada categoría ver la tabla 10.

Es aconsejable que cuando las puntuaciones de un sujeto se sitúen en el nivel «ansiedad severa» se lleve a cabo una intervención terapéutica, siendo esta intervención necesaria para los sujetos incluidos en el nivel «ansiedad extrema».

Tabla 10: Porcentaje aproximado de sujetos de los grupos «Normal» y «Clínico» incluidos en cada categoría

NIVEL	GRUPO	VARONES				MUJERES			
		C	F	M	T	C	F	M	T
Ansiedad Extrema	Normal	—	—	—	—	—	—	—	—
	Clínico	15	20	15	15	15	15	10	15
Ansiedad Severa	Normal	25	25	25	25	25	25	25	25
	Clínico	50	45	40	55	55	50	35	55
Ansiedad Moderada	Normal	50	50	50	50	50	50	50	50
	Clínico	35	35	40	30	30	35	45	30
Ansiedad Mínima	Normal	25	25	25	25	25	25	25	25
	Clínico	—	—	5	—	—	—	10	—

6. Ventajas y limitaciones del I. S. R. A.

Entre las características que requieren especial mención están las de tipo estructural, ya que el I.S.R.A. en su totalidad, así como cada una de sus partes, se ha mostrado como un inventario con gran capacidad de discriminación, alta fiabilidad y validez, y robusta estructura factorial, que apoya firmemente los presupuestos teóricos de que parte.

Presenta notables ventajas frente a otros autoinformes, especialmente frente a los tradicionales de rango, que ofrecen poca información, no tienen en cuenta las situaciones y se basan en un modelo ampliamente criticado (Mischel, 1968).

Frente a otros inventarios S-R, el I.S.R.A. muestra varias mejoras:

- Posee una taxonomía ambiental más amplia, al contar con más situaciones.
- Da oportunidad al sujeto de añadir una situación especialmente conflictiva para él y no incluida entre las anteriores.
- Las situaciones son más naturales, al estar relacionadas con el entorno habitual del sujeto. Sólo son potencialmente ansiógenas, evitándose las situaciones donde la respuesta de ansiedad fuese habitual, como, por ejemplo, «está escalando un elevado saliente en lo alto de una montaña» (de

Endler y cols., 1962), o «acabas de ser pillado en una ratería» y «estás solo en casa y oyes a alguien que intenta entrar» (de Magnusson y Ekehammar, 1975).

- Incluye un buen muestreo de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad.
- Posibilita la obtención del perfil cognitivo-fisiológico-motor del sujeto, así como una puntuación de rasgo obtenida a partir de las respuestas a todas las situaciones.
- Si se desea, pueden obtenerse perfiles cognitivo-fisiológico-motores de respuesta para cada situación, tal como propone Kazdin (1979) al hablar de la «especificidad situacional».

No obstante, el I.S.R.A. presenta algunas limitaciones al ser aplicado a determinados muestras, tales como pacientes psiquiátricos con alteraciones psicóticas, o sujetos con muy bajo nivel cultural. Esto se debe a que el I.S.R.A. requiere de un cierto nivel o grado de discriminación, lo que hace que resulte especialmente difícil para este tipo de personas. Siempre que se aplique en estos casos, el examinador debe tener en cuenta las indicaciones del apartado Aplicación.

En la actualidad se está trabajando en una versión abreviada y más simple que permita cubrir este campo.

7. Areas de aplicación del I. S. R. A.

La prueba ha sido elaborada con la finalidad de lograr una evaluación de la ansiedad más precisa que la que ofrecen las tradicionales pruebas de rasgo.

El proporcionar medidas de las respuestas del sujeto ante situaciones específicas y mostrar su patrón de respuestas, convierte al I.S.R.A. en un instrumento especialmente idóneo para ser utilizado en el ÁMBITO LABORAL, bien cuando se desee seleccionar personal con unas características determinadas que se ajusten a las necesidades del puesto a cubrir, bien cuando se desee comprobar el efecto de determinadas tareas o funciones sobre un individuo o grupo concretos.

En el ÁMBITO EDUCATIVO, además de las ventajas ya señaladas en cuanto a precisión y amplitud de la evaluación, permite un estudio más riguroso de las relaciones entre ansiedad y rendimiento, problemática escolar, etc.

En la INVESTIGACIÓN facilita la elaboración y puesta a prueba de nuevas hipótesis en la realización y/o réplica de distintos trabajos, tanto desde un enfoque conductual como interactivo. También simplifica notablemente la tarea de seleccionar muestras en función de la mayor o menor reactividad cognitiva, fisiológica o motora de los sujetos.

Ahora bien, donde indudablemente mostrará mayores ventajas es en el ÁMBITO CLÍNICO, tanto en la evaluación o diagnóstico como en el tratamiento.

En la evaluación proporciona un conocimiento más profundo de la ansiedad al ser abordado desde las tres vertientes posibles: cognitiva, fisiológica y motora. Además, facilita en gran medida el análisis funcional de la conducta al llevar a cabo una exploración sistemática, con un considerable ahorro de tiempo.

En el tratamiento sirve de guía sobre la técnica a emplear y como predictor del éxito de las diversas técnicas. Esto posibilita la utilización de las técnicas de reducción de ansiedad de una forma más individualizada y eficaz, empleando una técnica cuando predominan los componentes cognitivos, y otras distintas cuando el predominio sea fisiológico o motor.

En esta línea, Lang y cols. (1970) encontraron que los sujetos con mayor reactividad fisiológica mejoraban

más con una técnica de desensibilización sistemática. Wolpe (1977) incide sobre el mismo aspecto al señalar que la desensibilización sistemática es más efectiva si predomina el componente fisiológico que si predomina el componente cognitivo. Ost y cols. (1981), trabajando con sujetos que presentaban fobias sociales, encontraron que aquéllos que mostraban mayor reactividad fisiológica resultaban más beneficiados por la relajación que por el entrenamiento en habilidades sociales, mientras que en los sujetos con mayor reactividad motora la eficacia del tratamiento se invertía. Los mismos autores (Ost y cols., 1982), utilizando un diseño similar, pero esta vez con sujetos claustrofóbicos, encontraron resultados semejantes.

Como orientación a la hora de seleccionar la técnica de reducción de ansiedad más adecuada, aconsejamos:

De orientación predominantemente cognitiva:

- ⊗ Técnicas de autoinstrucciones.
- ⊗ Reestructuración cognitiva.
- ⊗ Técnicas de inoculación al stress.
- ⊗ Técnica de desvanecimiento (*fading*).

De orientación predominantemente fisiológica:

- ⊗ Entrenamiento en relajación.
- ⊗ Desensibilización sistemática.
- ⊗ Técnicas de *biofeedback*.

De orientación predominantemente motora o conductual:

- ⊗ Entrenamiento en habilidades sociales.
- ⊗ Práctica reforzada.

Respecto a las técnicas de inundación y exposición no existe un total acuerdo, siendo para algunos de predominio fisiológico (Vila, 1984) y para otros de predominio conductual o motor (Ost, 1985).

Finalmente, hemos de señalar que con el empleo de las técnicas mencionadas se logran resultados positivos, independientemente de la mayor reactividad específica del sujeto a tratar, aunque estos resultados serán superiores si se utiliza la técnica más adecuada al caso.

8. Rasgos específicos de ansiedad en el I.S.R.A.

8.1 — INTRODUCCION

Desde la aparición del Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (I.S.R.A.) en 1986, hemos seguido trabajando sobre la prueba con vistas a extraer de ella el máximo de información útil en la evaluación o diagnóstico psicológicos.

Nuestro propósito ha sido desarrollar los rasgos específicos o factores situacionales que aparecían en el análisis factorial de las situaciones que componen la prueba.

Tal como puso de relieve el enfoque interactivo, las reacciones de ansiedad están en función de las características personales, las condiciones situacionales y la interacción persona por situación. Según esto, toda manifestación de ansiedad es consecuencia de la interacción entre cierta predisposición existente en el individuo (rasgo) y las características de la situación en que tiene lugar la conducta.

Habitualmente el rasgo de ansiedad ha sido entendido de forma unidimensional, siendo definido como las diferencias individuales relativamente estables en cuanto a la propensión a la ansiedad. Es decir, los distintos individuos son, o somos, más o menos ansiosos, dependiendo de la mayor o menor propensión (rasgo) a la ansiedad. Esta concepción unidimensional de la ansiedad es la que sustenta la mayor parte de los cuestionarios, inventarios o escalas de ansiedad existentes.

Sin embargo, los trabajos de Endler y colaboradores han puesto de manifiesto la existencia de áreas situacionales ligadas a diferencias individuales en cuanto a rasgo de ansiedad, que pueden ser entendidas como rasgos específicos, dando lugar a una concepción multidimensional del rasgo de ansiedad.

A partir de la factorización realizada del S-R Inventory of Anxiousness (Endler y cols., 1962) se detectaron tres de estas áreas situacionales o rasgos específicos: Ansiedad interpersonal, ansiedad ante situaciones que implican peligro físico y ansiedad ante situaciones ambiguas o novedosas.

Posteriormente, y con el desarrollo del S-R Inventory of General Trait Anxiousness (Endler y Okada, 1975) se añadió a las anteriores la ansiedad ante la rutina cotidiana.

Por último (Endler, 1978; Flood y Endler, 1980) añaden una nueva dimensión: ansiedad ante la evaluación social.

A partir de los trabajos realizados con el I.S.R.A., y mediante el empleo del análisis factorial, se han detectado cuatro factores que corresponden a áreas situacionales o *rasgos específicos* (ver págs. 12-13); estos son:

FACTOR I: Ansiedad ante la Evaluación

Este factor viene definido por situaciones que implican ser evaluado y situaciones en que el individuo debe tomar decisiones o responsabilidades.

FACTOR II: Ansiedad Interpersonal

Definido por situaciones de carácter interpersonal, tales como las situaciones de tipo sexual o aquellas que implican relaciones directas con otros individuos.

FACTOR III: Ansiedad Fóbica

Este factor incluye situaciones en las que aparecen como elementos centrales estímulos típicamente fóbicos.

FACTOR IV: Ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana

En él destacan las situaciones que tienen que ver con el contexto y el quehacer diario y habitual del individuo.

Mayor información sobre estos factores y los *items* del I.S.R.A. que saturan en cada uno de ellos, así como sus respectivos pesos factoriales, puede verse en la página 13.

Estos factores o dimensiones guardan una relación de contenido bastante estrecha con los hallados por Endler y colaboradores en los distintos trabajos mencionados.

Las áreas situacionales señaladas, o rasgos específicos, poseen una cierta independencia entre sí (ver tabla de intercorrelaciones, pág. 13); de forma que pueden existir, como habitualmente se observa, sujetos con un alto nivel de ansiedad ante situaciones de evaluación y que no se muestran especialmente ansiosos ante situaciones habituales de su vida cotidiana; o que muestran diversas reacciones fóbicas sin que tengan una marcada dificultad en sus relaciones interpersonales, etc.

La constatación de estos rasgos específicos implica la existencia de un perfil individual específico en cuanto al tipo de situaciones capaces de generar ansiedad en los distintos sujetos. La detección de este perfil supone una evaluación mucho más exacta y predictiva que la obtenida mediante las clásicas pruebas de rasgo general de ansiedad.

Veamos algunos de los problemas que presentan las pruebas de rasgo general:

1. Las pruebas de rasgo general nos ofrecen únicamente una puntuación global que podemos interpretar como el grado en que un individuo

es ansioso. Sin embargo, no nos dicen nada, o muy poco, sobre el tipo de situaciones que generarán ansiedad en el sujeto.

2. Una misma puntuación en rasgo de ansiedad puede encubrir características diferentes en sujetos distintos. Se tiende a equiparar sujetos que muestran puntuaciones similares en rasgo cuando realmente éstos pueden ser muy diferentes. Veamos un ejemplo: imaginemos dos sujetos con una puntuación de 60 en una prueba «X» de rasgo de ansiedad; supuestamente la prueba clasifica a los dos sujetos como similares en cuanto a su rasgo de ansiedad. Sin embargo, el primero puede haber alcanzado esa puntuación porque en él las reacciones que debe valorar se producen principalmente ante situaciones interpersonales, mientras que en el caso del segundo, éstas se dan en situaciones habituales.
3. Los dos puntos anteriores llevan implícita la tan criticada escasa capacidad de predicción del rasgo (ver sobre este punto Mischel, 1968), ya que, como hemos visto, una única puntuación de rasgo general nos diría poco sobre el comportamiento individual ante situaciones concretas.

Frente a esto, la posibilidad que ofrece el I.S.R.A. de evaluar rasgos específicos nos permitirá, además de obtener una evaluación del rasgo general, realizar una evaluación detallada del perfil individual. Este perfil, además de eliminar en gran medida los problemas señalados y proporcionar la consiguiente mejora en la exactitud de la evaluación, nos dará mucha más información sobre la forma de orientar el tratamiento, al señalar las áreas especialmente ansiógenas para el sujeto.

Con vistas a la utilización del I.S.R.A. como prueba para evaluar la eficacia de un tratamiento, las fluctuaciones en el perfil nos indicarán si los cambios se están produciendo en la dirección deseada. Esta información, junto con la suministrada por las escalas de los sistemas de respuesta (C, F y M), convierten al I.S.R.A. en un instrumento de indudable valor para este fin.

8.2 — FUNDAMENTACION ESTADISTICA

Los datos que a continuación se muestran han sido obtenidos a partir de las muestras originales utilizadas en la elaboración del I.S.R.A. (ver pág. 9).

Para establecer las fórmulas de corrección que permitiesen la obtención de una puntuación para cada uno de los rasgos específicos (F-I, F-II, F-III y F-IV)

se partió del análisis factorial de las situaciones que componen el I.S.R.A. (ver pág. 13). El criterio seguido fue el de seleccionar aquellas situaciones que poseían un mayor peso factorial en cada uno de los factores y que no mostraban saturaciones en otros factores; aunque esto último no fue posible en algunos casos.

8.2.1. Capacidad de discriminación entre grupos

Con vistas a establecer la validez de los rasgos específicos, se llevó a cabo un estudio de discriminación entre los grupos «normal» y «clínico», realizando un análisis de varianza para cada uno de los rasgos específicos a partir de las puntuaciones obtenidas tras aplicar las fórmulas de corrección de dichos rasgos.

Los resultados se muestran en la tabla 11.

Como puede observarse, todos los rasgos específicos muestran una gran capacidad de discriminación entre los grupos «normal» y «clínico», siendo en todos los casos estas diferencias altamente significativas ($p < 0.0000$).

Tabla 11: Pruebas de discriminación entre los grupos «Normal» y «Clínico» para cada uno de los rasgos específicos

		Normal	Clínico	F	P
F-I	$\bar{X} \dots \dots$	77,14	111,56	92,58	0.0000
	$s_x \dots \dots$	19,56	34,99		
F-II	$\bar{X} \dots \dots$	19,56	28,97	44,30	0.0000
	$s_x \dots \dots$	11,21	16,14		
F-III	$\bar{X} \dots \dots$	39,56	65	73,19	0.0000
	$s_x \dots \dots$	26,44	30,24		
F-IV	$\bar{X} \dots \dots$	16,41	29,77	74,92	0.0000
	$s_x \dots \dots$	12,50	17,35		

8.3 — CORRECCION Y VALORACION

Para obtener la puntuación total de cada uno de los factores o rasgos específicos se procederá de la siguiente forma:

FACTOR I: Ansiedad ante la Evaluación

Se sumarán las puntuaciones correspondientes a las siguientes situaciones en las tres subescalas (C, F y M):

$$F-I = S1 + S4 + S8 + S10 + S11 + S13$$

Así, para obtener el valor de S1 deben sumarse los valores dados a la primera situación en C, F y M. Para S4 se hará lo mismo con la cuarta situación, y así sucesivamente.

FACTOR II: Ansiedad Interpersonal

$$F-II = S7 + S15 + S18$$

FACTOR III: Ansiedad Fóbica

$$F-III = S12 + S14 + S17 + S19$$

FACTOR IV: Ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana

$$F-IV = S5 + S21 + S22$$

Las cuatro puntuaciones obtenidas representan la puntuación directa de cada rasgo específico.

Estas puntuaciones directas se convierten en centiles utilizando las tablas de baremos (tablas 12 y 13). De esta forma conoceremos la posición que ocupa el individuo evaluado con respecto al grupo normativo correspondiente.

Al igual que en el caso de las puntuaciones C, F y M, relativas a los sistemas de respuestas, se aconseja

utilizar los baremos del grupo «Normal» para conocer la posición del sujeto respecto a la población general; y del grupo «Clínico» para valorar la severidad en cada rasgo con respecto a esa población.

Si se desea, se puede llevar a cabo un análisis más detallado sobre la capacidad de cada situación para desencadenar respuestas de ansiedad. Para ello se ten-

drá en cuenta el total de cada situación (suma de las puntuaciones de esa situación en C, F y M). Si se quiere comparar con otras, debe hallarse la media aritmética de cada una de ellas dividiendo la puntuación total de cada S entre el número de respuestas posibles en esa situación (número de casillas en blanco en C, F y M, para esa situación).

Tabla 12: Baremos de la muestra normal

P. centil	Puntuaciones directas								P. centil
	MUJERES				VARONES				
	FI	FII	FIII	FIV	FI	FII	FIII	FIV	
99	159	46	106	46	114	40	71	38	99
95	126	34	86	39	102	37	65	35	95
90	121	33	75	34	98	30	61	28	90
85	110	30	69	29	91	27	51	20	85
80	103	28	62	27	89	25	43	18	80
75	98	26	58	23	88	24	39	16	75
70	91	25	56	22	83	21	32	15	70
65	85	23	50	20	78	19	28	14	65
60	84	21	47	19	71	17	26	13	60
55	81	19	44	17	69	16	25	10	55
50	79	18	37	16	61	15	24	9	50
45	76	17	35	15	56	14	23	8	45
40	73	15	32	12	53	13	21	7	40
35	68	14	29	11	50	12	18	6	35
30	63	13	26	9	46	12	16	5	30
25	57	11	24	7	45	9	13	4	25
20	56	10	21	6	35	7	10	3	20
15	46	8	17	5	32	7	8	—	15
10	37	5	13	4	27	5	5	2	10
5	27	4	8	3	21	3	3	1	5

8.3.1. Elaboración del perfil

Una vez obtenidas las puntuaciones de cada rasgo específico mediante la aplicación de la fórmula correspondiente, se trasladarán los resultados a la hoja de perfil.

Para ello se seguirán los siguientes pasos:

- 1) La puntuación directa se convertirá en centil utilizando el baremo del grupo «Normal».

- 2) Las cuatro puntuaciones centiles (F-I, F-II, F-III y F-IV) se introducen en el gráfico a su altura correspondiente, realizando una marca en ese punto.

- 3) Si alguna de las puntuaciones directas supera a la indicada en el centil 99 del baremo del grupo «Normal», se introducirá en el gráfico dicha puntuación directa (sin transformar en centil),

tomando como referencia las puntuaciones indicadas en la hoja de perfil. Estas corresponden a los centiles 90, 95 y 99 del grupo «Clínico».

- 4) Si se unen mediante una línea las marcas reali-

zadas para las puntuaciones F-I, F-II, F-III y F-IV, se obtiene el perfil del sujeto. Si se elevan desde la base unas barras, se obtiene el diagrama de barras de los resultados empíricos comparados con los sujetos de la población.

Tabla 13: Baremos de la muestra clínica

P. centil	Puntuaciones directas								P. centil
	MUJERES				VARONES				
	FI	FII	FIII	FIV	FI	FII	FIII	FIV	
99	210	75	134	76	164	57	130	60	99
95	177	58	128	67	154	53	124	58	95
90	164	52	111	56	144	45	98	46	90
85	154	45	96	53	141	44	86	40	85
80	145	42	91	47	125	37	80	34	80
75	133	39	89	42	122	36	75	32	75
70	130	37	83	40	120	33	63	28	70
65	125	34	78	38	112	30	59	27	65
60	121	33	73	36	104	27	55	25	60
55	119	30	69	33	100	23	53	24	55
50	118	29	65	30	96	21	52	22	50
45	113	26	61	29	93	20	48	21	45
40	110	23	60	27	89	19	45	19	40
35	103	21	57	25	85	18	44	18	35
30	96	19	54	23	81	17	40	14	30
25	95	18	52	22	77	15	37	12	25
20	92	15	48	18	67	13	35	11	20
15	84	13	41	14	60	12	26	8	15
10	79	12	38	11	53	10	19	7	10
5	70	10	25	5	49	8	9	5	5

8.3.2. Interpretación del perfil

En el gráfico se han trazado tres líneas horizontales que corresponden a los centiles 25, 75 y 99 y que sirven como indicativo a la hora de interpretar los resultados.

Se delimitan así cuatro niveles de ansiedad:

- Ausencia de ansiedad o ansiedad mínima: en este nivel se encuentra el 25% de la población normal y ninguno, o un número muy reducido, de casos clínicos.

- Ansiedad moderada a marcada: aquí se incluye el 50% de la población normal y un número menor de sujetos con problemas clínicos.
- Ansiedad severa: en esta categoría se produce una inversión de las proporciones respecto al nivel anterior, encontrándose en ella el 25% de la población «normal» y un porcentaje considerablemente superior de sujetos «clínicos».
- Ansiedad extrema: todos los sujetos incluidos en

esta categoría pertenecen al grupo «clínico», sin que se haya detectado ningún caso del grupo «normal» que alcance estos valores.

En la tabla 14 se detalla el porcentaje de sujetos de los grupos «normal» y «clínico» incluido en cada nivel.

Como en el caso del perfil de sistemas de respuesta (C, F y M), se aconseja que cuando las puntuaciones de un sujeto se sitúen en el nivel de «ansiedad severa» se lleve a cabo una intervención terapéutica, siendo esta intervención necesaria para los sujetos incluidos en el nivel «ansiedad extrema».

Tabla 14: Porcentaje aproximado de sujetos de los grupos «Normal» y «Clínico» incluidos en cada categoría

NIVEL	CAMPO	VARONES				MUJERES			
		FI	FII	FIII	FIV	FI	FII	FIII	FIV
Ansiedad Extrema	Normal	—	—	—	—	—	—	—	—
	Clínico	25	20	30	20	15	15	10	20
Ansiedad Severa	Normal	25	25	25	25	25	25	25	25
	Clínico	40	25	50	50	55	40	45	45
Ansiedad Moderada	Normal	50	50	50	50	50	50	50	50
	Clínico	35	50	20	30	30	35	40	30
Ansiedad Mínima	Normal	25	25	25	25	25	25	25	25
	Clínico	—	5	—	—	—	10	5	5

Bibliografía

- BELLACK, A. S. y LOMBARD, T. W. (1984): «Measurement of Anxiety». En Turner, S. (Ed.), *Behavioral theories and treatment of anxiety*. Plenum Press, New York.
- BERMÚDEZ, J. (1983): «Modelo interactivo de ansiedad: implicaciones y contrastación empírica». *Revista de Psicología General y Aplicada*, 38, 1003-1030.
- BOWERS, K. S. (1972): «Situationism in psychology: on making reality disappear». *Research Report*, 3. Department of Psychology, University of Waterloo, Ontario, Canadá.
- (1973): «Situationism in psychology: an analysis and critique». *Psychological Review*, 80, 307-336.
- CANO VINDEL, A. (1985): *Estudio experimental sobre medidas de autoinforme: Influencia de las situaciones en la evaluación cognitiva de respuestas de ansiedad*. Memoria de Licenciatura. Facultad de Psicología. Universidad Complutense.
- ENDLER, N. S. (1973): «The person versus the situation a pseudo issue? A response to others». *Journal of Personality*, 41, 287-303.
- ENDLER, N. S.; HUNT, J. McV. y ROSENSTEIN, A. J. (1962): «An S-R Inventory of Anxiousness». *Psychological Monographs*, 76, núm. 17.
- ENDLER, N. S. y MAGNUSSON, D. (1974): «Interactionism, trait psychodynamics and situationism». *Report from the Psychological Laboratories*. University of Stockholm, 418.
- (1976): «Personality and person by situation interaction». En N. S. Endler y D. Magnusson (Eds.): *Interactional Psychology and Personality*, Hemisphere Publ. Washington, D. C.
- ENDLER, N. S. (1978): «The interaction model of anxiety. Some possible implications». En O. M. Landers y R. W. Christina (eds.): *Psychology of Motor Behavior and Sport*, 1977, Human Kinetics, Champaign, 332-351.
- ENDLER, S. S. y OKADA, M. (1975): «A multidimensional measure of trait anxiety: the S-R Inventory of General Trait Anxiousness». *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43, 319-329.
- FLOOD, M. y ENDLER, N. S. (1980): «The interaction model of anxiety: An empirical test in an athletic competition situation». *Journal of Research in Personality*, 14, 329-339.
- KAZDIN, A. E. (1973): «The effect of suggestion and pretesting on avoidance reduction in fearful subjects». *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 4, 213-222.
- LANG, P. J. (1968): «Fear reduction and fear behavior: problems in treating a construct». En SHILEN, J. M. (Ed.): *Research in psychotherapy*, vol. III. American Psychological Association, Washington.
- LANG, P. J.; MELAMED, B. G. y HART, J. (1970): «A psychophysiological analysis of fear modification using and automated desensitization procedure». *Journal of Abnormal Psychology*, 76, 220-234.
- MAGNUSSON, D. y EKEHAMMAR, B. (1975): «Perceptions of and Reactions to stressful situations». *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 1147-1154.
- MARTIN, B. y SROUFE, L. A. (1970): «Anxiety». En C. G. Costello (Ed.): *Symptoms of psychopathology: A handbook*. Wiley, New York.
- MIGUEL TOBAL, J. J. (1985): *Evaluación de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad: Elaboración de un instrumento de medida (I.S.R.A.)*. Tesis doctoral. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- MIGUEL TOBAL, J. J. y CANO VINDEL, A. (1984): «Desarrollo de un Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (I.S.R.A.)». En C.O.P. (Ed.): *Libro de Comunicaciones del I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos*, Madrid.
- (1984b): *Evaluación de respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras de ansiedad*. Symposium sobre Actividad Humana y Procesos Cognitivos, Madrid.
- MISCHEL, W. (1968): *Personality and Assessment*, Wiley, New York. (Existe traducción al castellano: «Personalidad y evaluación», Trillas, México, 1973).
- PAUL, G. L. y BERNSTEIN, D. A.: *Anxiety and clinical problems: Systematic desensitization and related techniques*. General Learning Press, New York.
- OST, L. G. (1985): «Ways of acquiring phobias and outcome of behavioral treatments». 15 th. Annual Meeting. European Association for Behavior Therapy. München.
- OST, L. G.; JERRELMALM, A. y JOHANSSON, J. (1981): «Individual response patterns and the effects of different behavioral methods in the treatment of social phobia». *Behaviour Research and Therapy*, 19, 1-16.
- OST, L. G.; JOHANSSON, J. y JERRELMALM, A. (1982): «Individual response pattern and the effects of different behavioral methods in the treatment of claustrophobia». *Behaviour Research and Therapy*, 20, 445-460.
- SPIELBERGER, C. D.; GORSUCH, R. I. y LUSHENE, R. (1970): *The State-Trait Anxiety Inventory (self-evaluation Questionnaire)*. Psychologists Press, Palo Alto, California.
- (1982): *Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. Manual*. TEA Ediciones, S. A., Madrid.
- TAYLOR, J. A. (1953): «A personality Scale of manifest anxiety». *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 48, 275-280.
- VILA, J. (1984): «Técnicas de reducción de ansiedad». En MAYOR, J. y LABRADOR, F. J. (Eds.): *Manual de modificación de conducta*, Alhambra, Madrid.
- WOLPE, J. (1977): «Inadequate behavior analysis: The Achilles' heel of outcome research in behavior therapy. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 8, 1-3.

INDICE

	Págs.
1. – INTRODUCCION	3
1.1 – Las teorías interactivas	3
1.2 – El enfoque neoconductista	4
1.3 – Aportaciones de los enfoques interactivo y conductual a la evaluación de la ansiedad	5
2. – OBJETIVOS	5
3. – DESCRIPCION GENERAL	6
3.1 – Ficha técnica	6
3.2 – Estructura del Inventario	6
3.3 – Elaboración	6
3.4 – Descripción de las subescalas	7
3.5 – Material de la prueba	8
4. – FUNDAMENTACION ESTADISTICA	9
4.1 – Descripción de las muestras	9
4.2 – Poder de discriminación entre grupos	10
4.3 – Consistencia interna	10
4.4 – Fiabilidad	11
4.5 – Análisis factorial de las respuestas	11
4.6 – Análisis factorial de las situaciones	12
4.7 – Validez	14
5. – INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION Y CORRECCION.	15
5.1 – Aplicación	15
5.2 – Corrección y valoración	15
5.3 – Elaboración del perfil	17
5.4 – Interpretación del perfil	18
6. – VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL I.S.R.A.	19
7. – AREAS DE APLICACION DEL I.S.R.A.	20
8. – RASGOS ESPECIFICOS DE ANSIEDAD EN EL I.S.R.A.	21
8.1 – Introducción	21
8.2 – Fundamentación estadística	22
8.3 – Corrección y valoración	23
BIBLIOGRAFIA	27

Algunas publicaciones que distribuye TEA Ediciones, S. A.

1 - Escalas y tests de inteligencia general:

- A) *Individuales:* Escala de Alexander, Escala Borelli-Oleron, Escala de desarrollo de Gessell, Escalas Bayley de Desarrollo Infantil, Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad, Etapas de la inteligencia sensorio-motriz de Piaget, Terman-Merrill, WAIS, WISC, WPPSI.
- B) *Colectivos:* AMPE elemental, Tests de aptitudes cognoscitivas, Aptitudes generales inferior, Batería de aptitudes generales, BETA, CC-78, CM-76, D-48, D-70, Tests de factor «g» (Escala 1, 2 y 3), Otis sencillo, TEI (Formas A y B), TIG-1, TIG-2.

2 - Tests de aptitudes:

- A) *Baterías generales:* ABI, AMD-77, AMDI, AMPE factorial, APT, Batería diferencial de la inteligencia, Batería operarios, Batería subalternos, BPA (Niveles 1 y 2), DAT, Decatest, PMA, SAE, TEA (Niveles 1, 2 y 3).
- B) *Razonamiento:* AMPE-R, APT-RA, DAT-AR, Decatest-RC, PMA-R, TEA-R.
- C) *Aptitudes verbales:* COE (Formas 1 y 2), Índice lexicultural, TCV.
- D) *Aptitudes numéricas:* Monedas (Formas 1 y 2), TN (Formas 1 y 2).
- E) *Aptitudes espaciales y mecánicas:* Aptitudes mecánicas MacQuarrie, Desarrollo de superficies, Test de mecánica, Test de oficios, Palancas, Rompecabezas impresos, Rotación de figuras macizas.
- F) *Aptitudes perceptivas y de atención:* Caras, Consonantes, Cuadrados de letras, Formas idénticas, Toulouse-Pieron, Vocales.
- G) *Memoria:* MAI, MS-76, MY-Test de Memoria, Ordenes de oficina.
- H) *Destreza manual y motora:* Coordinación bimanual, Coordinación visomotora, Test de destreza de Crawford, Test de destreza de Bennett, Test de destreza de Stromberg, Rapidez motora.
- I) *Aptitudes administrativas:* BTA, GCT, IC (Formas A y B), SET.
- J) *Aptitudes y conocimientos artísticos:* Test de apreciación de dibujos, Test de capacidades musicales.

3 - Personalidad, intereses y tests clínicos:

- A) *Cuestionarios de personalidad y adaptación:* BELL, CACIA, CAQ, CDS (Depresión infantil), CEP, CET-DE, CPQ, EPI, EPQ-A y J, ESPQ, HSPQ, IAC, IPV, ISRA, MMPI (colectivo e individual), PEI, 16-PF, PNP, STAI (Ansiedad Estado Rasgo), TAMAI de adaptación infantil, TP-76.
- B) *Cuestionarios de Intereses, Hábitos, Actitudes:* BAS (socialización), CIPSA, Escalas clima social: FES (Familia), WES (Trabajo), CIES (Inst. Penitenciarias) y CES (Centro Escolar), IHE, Intereses Profesionales, KUDER, SIV, SPS, TAV, TV-76.
- C) *Tests proyectivos y clínicos:* ABC de dominancia ocular, Test para el examen de la afasia, Columbia, Copia de una figura compleja (Rey), Esquema Corporal, Fábulas de Düss, Test de formación de conceptos de Hanfman Kasanin, FROSTIG, HARRIS, test de dominancia lateral, Laberintos de Porteus, Lateralidad usual, «Pata negra», Praxia constructiva tridimensional, Reversal test, Rorschach, RTVB, test de Retención Visual de Benton, Szondi Test, TAT, CAT-A, CAT-H y TAT-Escolar, Test Z.

4 - Pruebas pedagógicas y de rendimiento:

- A) *Pedagógicas y de Rendimiento:* BAPAE, Batería Pedagógica (Evaluación lengua castellana), BOEHM, LC (Lectura Comprensiva), CLOZE, COLE (Niveles 1 y 2), Diagnóstico del Nivel de información, EDIL-1, FILHO (ABC), ITPA (Prueba Illinois de Habilidades Psicolingüísticas), Mecanografía, Ortografía-2, Preescolar, Pruebas de lectura (1 y 2), Valett (Evaluación del desarrollo de las aptitudes básicas para el aprendizaje).
- B) *Recuperación, Terapia:* Corrección enuresis, FROSTIG, Guía Portage de educación preescolar, PDA, PROPV, Psicoterapia Multidimensional.

5 - Varios:

- A) *Tests diversos:* Desarrollo de la entrevista, Escala de calificación de personal, EFT (Figuras enmascaradas), Ficha psicopedagógica, P. IP-Prediagnóstico Infantil.
- B) *Documentos y material auxiliar:* Impresos para análisis profesiográficos, Impresos para cálculos estadísticos, Cronómetros.

Material en versión catalana:

WISC, COLE, HSPQ, IPV.

Libros:

Aprender a estudiar, Didáctica del Estudio, Entrenamiento autógeno para Niños, Adolescentes y Padres, Esquema Corporal, Evaluación clínica de los niños con las Escalas McCarthy, Evaluación del proceso educativo, Expresión corporal, Fábulas de Düss, Interpretación clínica del WAIS, Interpretación clínica del WISC, Manual del Entrevistador, MMPI-Suplemento, 16PF-Monografía técnica, Normas sobre tests y manuales educativos y psicológicos, 16PF-Guía para su uso clínico e interpretación clínica, Psicoterapia multidimensional, Tests y documentos psicológicos, Una validación clínica del test Szondi.

- * Distribución para España del material psicotécnico de «The Psychological Corporation» (New York), «Institute for Personality and Ability Testing» (Champaign, Illinois), «Consulting Psychologists Press, Inc.» (Palo Alto, California), «Science Research Associates, Inc.» (Chicago), «Houghton Mifflin Company» (Boston), AGS, «American Guidance Service» (Minneapolis), «Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée» (Paris), «Hodder and Stoughton Educational» (Kent, Great Britain), «Hans Huber» (Berna, Suiza).



Fray Bernardino de Sahagún 24 Tel: 4588311 (10 líneas) 28036-MADRID

A. FORMULAS DE CORRECCION

$$F-I = S1 + S4 + S8 + S10 + S11 + S13$$

$$F-II = S7 + S15 + S18$$

$$F-III = S12 + S14 + S17 + S19$$

$$F-IV = S5 + S21 + S22$$

B. PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACION DEL PERFIL

Una vez obtenidas las puntuaciones de cada rasgo específico mediante la aplicación de la fórmula correspondiente, se trasladarán los resultados a la Hoja de perfil.

Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. La puntuación directa se convertirá en centil, utilizando el baremo del grupo «Normal».
2. Las cuatro puntuaciones centiles obtenidas (F-I, F-II, F-III y F-IV) se introducen en el gráfico a su altura correspondiente, realizando una marca en ese punto.
3. Si alguna de las puntuaciones directas supera a la indicada en el centil 99 del baremo del grupo «Normal», se introducirá en el gráfico dicha puntuación directa (sin transformar en centil), tomando como referencia las puntuaciones indicadas en la hoja de perfil. Estas corresponden a los centiles 90, 95 y 99 del grupo «Clínico».
4. Si se unen mediante una línea las marcas realizadas para las puntuaciones F-I, F-II, F-III y F-IV, se obtiene el perfil del sujeto. Si se elevan desde la base unas barras, se obtiene el diagrama de barras de los resultados empíricos, comparados con los sujetos de la población.

Es aconsejable que, cuando las puntuaciones de un sujeto se sitúen en el nivel «ansiedad severa», se lleve a cabo una intervención terapéutica, siendo esta intervención necesaria para los sujetos incluidos en el nivel «ansiedad extrema».



Autores: J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel

Copyright © 1986, 1988 by TEA Ediciones, S. A. - Todos los derechos reservados - Prohibida la reproducción total o parcial - Edita: TEA Ediciones, S. A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 Madrid - Imprime: Aguirre Campano; Daganzo, 15 dpdo.; 28002 Madrid - Depósito legal: M.-39.798-1988.

HOJA DE PERFIL (RASGOS ESPECIFICOS)

Apellidos y nombre Edad Sexo

(V o M)

Centro Curso/Puesto Estado civil

Otros datos Fecha

Puntuaciones directas					
Puntuaciones centiles					Clasificación
	F-I	F-II	F-III	F-IV	
Centiles	203 y + ⊕	75 y + ⊕	134 y + ⊕	73 y + ⊕	ANSIEDAD EXTREMA
	185 ⊕	57 ⊕	127 ⊕	62 ⊕	
	169 ⊕	50 ⊕	111 ⊕	53 ⊕	
99	⊕	⊕	⊕	⊕	
95	⊕	⊕	⊕	⊕	ANSIEDAD SEVERA
90	⊕	⊕	⊕	⊕	
85	⊕	⊕	⊕	⊕	
80	⊕	⊕	⊕	⊕	
75	⊕	⊕	⊕	⊕	
70	⊕	⊕	⊕	⊕	DE ANSIEDAD MODERADA A ANSIEDAD MARCADA
65	⊕	⊕	⊕	⊕	
60	⊕	⊕	⊕	⊕	
55	⊕	⊕	⊕	⊕	
50	⊕	⊕	⊕	⊕	
45	⊕	⊕	⊕	⊕	
40	⊕	⊕	⊕	⊕	
35	⊕	⊕	⊕	⊕	
30	⊕	⊕	⊕	⊕	
25	⊕	⊕	⊕	⊕	
20	⊕	⊕	⊕	⊕	AUSENCIA DE ANSIEDAD O ANSIEDAD MINIMA
15	⊕	⊕	⊕	⊕	
10	⊕	⊕	⊕	⊕	
5	⊕	⊕	⊕	⊕	

Véanse instrucciones al dorso →

Apellidos y nombre Edad Sexo
 Centro Curso/Puesto Estado civil (V o M)
 Otros datos Fecha

INSTRUCCIONES

En las páginas siguientes encontrará una serie de frases que presentan **situaciones** en que usted podría encontrarse y otras que se refieren a **respuestas** que usted podría dar ante esas situaciones o reacciones que le producirían.

Las situaciones aparecen numeradas en la parte izquierda de la página y las respuestas posibles están indicadas en la parte superior.

Su tarea consiste en valorar de 0 a 4 la **frecuencia** con que se da en usted cada respuesta o reacción que está considerando, según la siguiente escala:

0: Casi nunca 1: Pocas veces 2: Unas veces si y otras no 3: Muchas veces 4: Casi siempre

Vea los ejemplos siguientes:

0	CASI NUNCA
1	POCAS VECES
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO
3	MUCHAS VECES
4	CASI SIEMPRE

SITUACIONES	RESPUESTAS					OBSERVACIONES
	1. Me desconcierto; no sé qué hacer.	2. Tengo la impresión de que soy un inútil.	3. No puedo concentrarme en el trabajo.	4. Tengo dificultades para dormir.	5. Pierdo el apetito.	
1. Si un problema me preocupa mucho,						
2. Cuando pierdo un objeto que tenía en mucha estima,						

Deberá leer la situación 1 y cada una de las respuestas que están sobre la columna en que hay casillas en blanco (en el primer caso las columnas 2 y 4). Cuando las haya leído, decida qué número poner en la casilla correspondiente. Hágalo. Conteste después a la situación 2. Habrá dado sus contestaciones en las casillas que corresponden a las respuestas 1, 2 y 5. ¿Lo ha hecho así? ¿Tiene alguna dificultad?

CONTESTE A TODAS LAS CASILLAS EN BLANCO

La última cuestión (la núm. 23) se utilizará sólo cuando exista una situación especialmente perturbadora para usted y no esté incluida en las 22 anteriores. En ese caso, escriba la situación en el lugar correspondiente de las tres páginas y ponga su valoración en las casillas que crea conveniente.

Si desea precisar más o hacer alguna observación, utilice el margen derecho de la Hoja (OBSERVACIONES).



Autores: J. J. Miguel Tobal y A. R. Cano Vindel

Copyright © 1986 by TEA Ediciones, S. A. - Todos los derechos reservados - Prohibida la reproducción total o parcial - Edita: TEA Ediciones, S. A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 Madrid - Imprime: Aguirre Campano; Daganzo, 15 duplicado; 28002 Madrid - Depósito legal: M. - 5.757 - 1986.

C

0	CASI NUNCA
1	POCAS VECES
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO
3	MUCHAS VECES
4	CASI SIEMPRE

SITUACIONES	RESPUESTAS							OBSERVACIONES	ΣS
	1. Me preocupo fácilmente.	2. Tengo pensamientos o sentimientos negativos o sobre mí, tales como "inferior" a los demás, "torpe", etc.	3. Me siento inseguro de mí mismo.	4. Doy demasiadas vueltas a las cosas sin llegar a decidirme.	5. Siento miedo.	6. Me cuesta concentrarme.	7. Pienso que la gente se dará cuenta de mis problemas o de la torpeza de mis actos.		
1. Ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante.									
2. Cuando voy a llegar tarde a una cita.									
3. Cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer.									
4. A la hora de tomar una decisión o resolver un problema difícil.									
5. En mi trabajo o cuando estudio.									
6. Cuando espero a alguien en un lugar concurrido.									
7. Si una persona del otro sexo está muy cerca de mí, rozándome, o si estoy en una situación sexual íntima.									
8. Cuando alguien me molesta o cuando discuto.									
9. Cuando soy observado o mi trabajo es supervisado, cuando recibo críticas, o siempre que pueda ser evaluado negativamente.									
10. Si tengo que hablar en público.									
11. Cuando pienso en experiencias recientes en las que me he sentido ridículo, tímido, humillado, solo o rechazado.									
12. Cuando tengo que viajar en avión o en barco.									
13. Después de haber cometido algún error.									
14. Ante la consulta del dentista, las inyecciones, las heridas o la sangre.									
15. Cuando voy a una cita con una persona del otro sexo.									
16. Cuando pienso en mi futuro o en dificultades y problemas futuros.									
17. En medio de multitudes o en espacios cerrados.									
18. Cuando tengo que asistir a una reunión social o conocer gente nueva.									
19. En lugares altos, o ante aguas profundas.									
20. Al observar escenas violentas.									
21. Por nada en concreto.									
22. A la hora de dormir.									
23. Escriba una situación en la que usted manifiesta frecuentemente alguna de estas respuestas o conductas.									
ΣR								TOTAL	

ASEGURESE DE HABER RELLENADO TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO

0	CASI NUNCA
1	POCAS VECES
2	UNAS VECES SI OTRAS VECES NO
3	MUCHAS VECES
4	CASI SIEMPRE

0 CASI NUNCA		1 POCAS VECES		2 UNAS VECES SI OTRAS VECES NO		3 MUCHAS VECES		4 CASI SIEMPRE	
SITUACIONES									
1. Ante un examen en el que me juego mucho, o si voy a ser entrevistado para un trabajo importante.									
2. Cuando voy a llegar tarde a una cita.									
3. Cuando pienso en las muchas cosas que tengo que hacer.									
4. A la hora de tomar una decisión o resolver un problema difícil.									
5. En mi trabajo o cuando estudio.									
6. Cuando espero a alguien en un lugar concurrido.									
7. Si una persona del otro sexo está muy cerca de mí, rozándome, o si estoy en una situación sexual íntima.									
8. Cuando alguien me molesta o cuando discuto.									
9. Cuando soy observado o mi trabajo es supervisado, cuando recibo críticas, o siempre que pueda ser evaluado negativamente.									
10. Si tengo que hablar en público.									
11. Cuando pienso en experiencias recientes en las que me he sentido ridículo, tímido, humillado, solo o rechazado.									
12. Cuando tengo que viajar en avión o en barco.									
13. Después de haber cometido algún error.									
14. Ante la consulta del dentista, las inyecciones, las heridas o la sangre.									
15. Cuando voy a una cita con una persona del otro sexo.									
16. Cuando pienso en mi futuro o en dificultades y problemas futuros.									
17. En medio de multitudes o en espacios cerrados.									
18. Cuando tengo que asistir a una reunión social o conocer gente nueva.									
19. En lugares altos, o ante aguas profundas.									
20. Al observar escenas violentas.									
21. Por nada en concreto.									
22. A la hora de dormir.									
23. Escriba una situación en la que usted manifiesta frecuentemente alguna de estas respuestas o conductas.									
.....									
.....									
ΣR									
TOTAL									